

Hep-B (Engerix): Ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά του ιού της ηπατίτιδας B.

- * Όταν η μητέρα είναι φορέας του ιού της ηπατίτιδας B (HBsAg+), τότε η 1^η δόση του μονοδύναμου εμβολίου HepB, καθώς και 0,5 ml υπεράνοσης γ-σφαιρίνης έναντι του ιού της ηπατίτιδας B (HBIG), πρέπει να χορηγηθούν ταυτόχρονα και σε διαφορετικά σημεία εντός 12 ωρών από τη γέννηση. Στην περίπτωση αυτή αναγκαστικά η 1^η δόση του HepB χορηγείται ως μονοδύναμο εμβόλιο.
- * Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η κατάσταση φορίας της μητέρας, τότε η 1^η δόση του εμβολίου HepB πρέπει να χορηγείται εντός 12 ωρών από τη γέννηση. Στη συνέχεια να γίνεται άμεσα έλεγχος για επιφανειακό αντιγόνο (HBsAg) στη μητέρα και αν είναι θετική, να χορηγείται και HBIG στο νεογνό, όχι αργότερα από την ηλικία της μίας εβδομάδος.
- * Στην περίπτωση που η 1^η δόση χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση, τότε ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει συνολικά 4 δόσεις αντί για 3 δόσεις (η 2^η στο τέλος του 1^{ου} μήνα και η 3^η δόση στο τέλος του 2^{ου} μήνα). Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ 1^{ης} και 2^{ης} καθώς και 2^{ης} και 3^{ης} δόσης είναι 4 εβδομάδες. Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ της προτελευταίας (3^{ης}) και τελευταίας (4^{ης}) δόσης του βασικού εμβολιασμού είναι 8-16 εβδομάδες και δεν χορηγείται νωρίτερα από την ηλικία των 24 εβδομάδων (6 μηνών).
- * Όλα τα παιδιά των μητέρων-φορέων πρέπει να ελέγχονται μετά την συμπλήρωση και των 3 δόσεων HepB εμβολίου, στην ηλικία 9-18 μηνών για HbsAg και anti-HBs. Επανάληψη όλων των δόσεων εμβολίου Hep-B απαιτείται πολύ σπάνια στα παιδιά θετικών μητέρων, τα οποία ενώ εμβολιάστηκαν κανονικά στη γέννηση, τελικά δεν ανέπτυξαν επαρκή τίτλο αντισωμάτων (εμφανίζουν δηλαδή anti-HBs $\leq$ 10 mIU/ml).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που το εμβόλιο της Ηπατίτιδος B χορηγηθεί ως συνδυασμένο εμβόλιο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι *τα συνδυασμένα εμβόλια δεν χορηγούνται πριν από την 6^η εβδομάδα της ζωής. Επομένως, το ελάχιστο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί από τη γέννηση, που χορηγείται το μονοδύναμο εμβόλιο της Ηπατίτιδας B, είναι 6 εβδομάδες αντί 1 μήνας.*

- * Παράλληλα με τη χορήγηση 1^{ης} δόσης του εμβολίου, σε όλα τα νεογνά μητέρων φορέων του επιφανειακού αντιγόνου (HBsAg) και μέσα στις πρώτες 12 ώρες μετά τη γέννηση, χορηγούνται 0,5 ml υπεράνοσης ανοσοσφαιρίνης για την ηπατίτιδα B (HBIG). Η ένεση εκτελείται σε διαφορετικό ανατομικό σημείο από αυτό που έγινε (ή θα γίνει) το εμβόλιο. Όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες φορείς και έλαβαν το εμβόλιο και την υπεράνοση ανοσοσφαιρίνη, πρέπει να ελέγχονται για επιφανειακό αντιγόνο (HBsAg) και για αντισώματα (αντι-HBs) στην ηλικία των 9 έως 15 μηνών.
- * Όταν η μητέρα είναι άγνωστο αν είναι ή όχι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου της Ηπατίτιδας B (HBsAg) κατά τον τοκετό και στη συνέχεια αποδειχτεί ότι δεν είναι, από τη 2^η δόση και πέρα ακολουθείται το σχήμα του εμβολιασμού που ισχύει για τα νεογνά μητέρων που δεν είναι φορείς του HbsAg, δηλαδή αγνοείται η 1^η δόση.
- * Όταν η μητέρα είναι αρνητική για το επιφανειακό αντιγόνο, τότε ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει 3 δόσεις (δύο αρχικές με μεσοδιάστημα 6-8 εβδομάδων και μια τρίτη σε ηλικία 6-18 μηνών, με ελάχιστο μεσοδιάστημα από τη 2^η δόση τις 8-16 εβδομάδες και όχι νωρίτερα από την ηλικία των 6 μηνών).

Στην Ελλάδα, από το 1998 θεσπίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όλων των βρεφών. Ανεμβολίαστα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, θα πρέπει να εμβολιασθούν μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Είναι απαραίτητο, επίσης, να εφαρμόζεται το εμβόλιο και σε όλα τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. | 5. Ιδρυματικοί ασθενείς. |
| 2. Σπουδαστές επαγγελματιών υγείας. | 6. Ομοφυλόφιλοι, τοξικομανείς. |
| 3. Αιμοκαθαρόμενοι. | 7. Ιερόδουλες. |
| 4. Πολυμεταγγιζόμενοι. | 8. Μέλη οικογένειας φορέων. |